RAPORT MEDICAL UNIFICAT

Reacții adverse, interacțiuni farmacologice și precauții specifice pentru Jamesi și Triplixam

Pacient: Petrilă Viorel-Mihai (66 ani, CNP 1590518024486)

Data raportului: 18 aprilie 2026

Autor: Sinteză unificată pe baza documentației furnizate (rapoarte Claude Code v1.0, Gemini, PDF ChatGPT, fișiere JSON pacient și dosar medical)

Versiune: 1.0 – Document complet și exhaustiv

ATENȚIONARE IMPORTANTĂ

Acest raport unifică integral toate documentele atașate (cele două fișiere .docx, PDF-ul de 9 pagini, fișierele JSON din dosarul medical și explicațiile anterioare privind acidoza lactică și ciclul Cori). Informațiile sunt extrase exclusiv din sursele oficiale citate în documente (RCP Janumet/Triplixam 2021–2024, studii peer-reviewed). Raportul **NU înlocuiește consultul medical**. Orice decizie terapeutică aparține medicului curant sau radiologului. În caz de urgență sunați 112.

---

1. Introducere și contextul pacientului

Pacientul Petrilă Viorel-Mihai (n. 18.05.1959) este diagnosticat cu diabet zaharat tip 2 și hipertensiune arterială esențială, cu antecedent de sindrom coronarian acut (stent pe arteră interventriculară anterioară, februarie 2012). Tratamentul actual include:

- **Jamesi 50 mg/1000 mg** (sitagliptin + metformin) – control glicemic.
- **Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg** (perindopril + indapamidă + amlodipină) – control tensional.

Ambele medicamente sunt combinații fixe cu profil de siguranță bine documentat, însă interacțiunea lor cu contrastul iodat (CT torace-abdomen-pelvis programat luni, 20 aprilie 2026) impune precauții stricte.

---

2. Descrierea medicamentelor (sinteză unificată)

Medicament	Substanțe active	Mecanism principal	Doză actuală

Jamesi	Sitagliptin 50 mg + Metformin HCl 1000 mg	Inhibitor DPP-4 + biguanidă (↓ producție hepatică de glucoză + ↑ sensibilitate la insulină)	1 cpr × 2/zi cu mese
Triplixam	Perindopril arginină 10 mg + Indapamidă 2,5 mg + Amlodipină 5 mg	IECA + diuretic tiazid-like + blocant canale Ca^{2+}	1 cpr dimineața

---

3. Reacții adverse principale (clasificate după frecvență și gravitate)

Jamesi (din RCP Janumet + rapoartele atașate)

- **Foarte frecvente (>1/10):** greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, gust metalic, scădere apetit.
- **Frecvente:** dureri de cap, infecții respiratorii, scădere vitamină B12 (după luni/ani).
- **Rare/Grave:** pancreatită acută, reacții alergice severe (inclusiv angioedem), insuficiență renală acută, acidoză lactică.

Triplixam (din RCP Servier + rapoartele atașate)

- **Foarte frecvente:** edem glezină (amlodipină), tuse seacă (perindopril).
- **Frecvente:** amețeli, hipotensiune ortostatică, hipokaliemie (indapamidă).
- **Rare/Grave:** angioedem (perindopril), hiponatremie, hiperuricemie, reacții cutanate severe.

Interacțiuni critice la acest pacient (sinteză unificată)

1. **Jamesi + Triplixam → risc crescut angioedem** (perindopril + sitagliptin blochează ambele căi de degradare a bradikininei).
2. **Metformin + contrast iodat → acidoză lactică** (principalul risc pre-CT).
3. **Indapamidă + contrast iodat → insuficiență renală acută** (deshidratare + toxicitate renală).

---

4. Explicație detaliată: Acidoza lactică (mecanism, riscuri, prevenție)

Acidoza lactică este o complicație metabolică rară (3–10 cazuri/100.000 pacienți/an), dar

cu mortalitate 30–50 % dacă nu este tratată prompt. Apare prin acumularea excesivă de acid lactic (>5 mmol/L) și scăderea pH-ului sanguin (<7,35).

Mecanism detaliat (legat de ciclul Cori):
Ciclul Cori permite reciclarea lactatului produs în mușchi (glicoliză anaerobă) în glucoză hepatică. Metforminul inhibă complexul I mitocondrial hepatic, reducând producția de ATP și capacitatea ficatului de a efectua gluconeogeneza din lactat. În condiții de funcție renală compromisă (deshidratare, contrast iodat), metforminul se acumulează, iar ciclul Cori este blocat → acidoză lactică.

Simptome de urgență (sunați 112): respirație Kussmaul, greață/vărsături severe, durere abdominală/musculară intensă, confuzie, somnolență, extremități reci.

Prevenție specifică pentru CT (20.04.2026):

- **Jamesi** – Opriți complet începând cu **sâmbătă 18 aprilie 2026, ora 17:00** (pauză 48 ore înainte). Reluați miercuri 22 aprilie 2026 ora 17:00 **numai după analize de creatinină/eGFR normale**.
- **Triplixam** – Continuați schema normală. Asigurați hidratare activă duminică 19 aprilie (1,5–2 L apă plată). Întrebați radiologul explicit dacă doza de luni dimineața se omite.

---

5. Mecanismul detaliat al ciclului Cori (explicație unificată)

Ciclul Cori (descoperit de C. & G. Cori) este calea metabolică care reciclează lactatul muscular în glucoză hepatică, prevenind acidoza lactică în condiții normale.

Etape:

1. **Mușchi (glicoliză anaerobă):** Glucoza → 2 piruvat (+2 ATP) → lactat (via LDH, regenerare NAD^+).
2. **Transport:** Lactat → ficat via sânge.
3. **Ficat (gluconeogeneză):**
    - Lactat → piruvat (LDH)
    - Piruvat → oxaloacetat (piruvat carboxilază, –1 ATP)
    - Oxaloacetat → fosfoenolpiruvat (PEPCK, –1 GTP)
    - Continuare până la glucoză (bypass-uri enzimatice).

Bilanț net: –4 ATP pe ciclu. Metforminul perturbă acest ciclu prin inhibiție mitocondrială, crescând riscul de acidoză lactică la stres renal.

---

6. Checklist pre-CT (20 aprilie 2026) – acțiuni obligatorii

- **Sâmbătă 18.04.2026 ora 17:00:** Opriți Jamesi.
- **Duminică 19.04.2026:** Hidratare 1,5–2 L apă; continuați Triplixam.
- **Luni 20.04.2026:** Prezentați acest raport radiologului; confirmați dacă Triplixam se menține.
- **După CT:** Analize creatinină/eGFR înainte de reluarea Jamesi (miercuri 22.04.2026 ora 17:00).
- **Urgențe imediate:** umflare față/buze/limbă, durere abdominală severă, respirație anormală → 112.

---

7. Surse unificate (toate documentele atașate)

- RCP Janumet (emc.medicines.org.uk, 2024).
- RCP Triplixam (Servier 06.2021 + Rwanda FDA 2023).
- Rapoarte Claude Code, Gemini și PDF ChatGPT (18.04.2026).
- Fișiere JSON dosar medical (stent 2012, analize 2024–2025).
- Explicații biochimice standard (ciclul Cori – PubChem Pathway WP1946).

Concluzie

Combinația Jamesi + Triplixam este eficientă și sigură în condiții obișnuite, însă necesită precauții stricte înainte de orice procedură cu contrast iodat pentru a evita acidoza lactică și insuficiența renală acută. Respectarea pauzei de 48 ore pentru Jamesi și hidratarea adecvată reduc riscul la minimum.

Acest raport reprezintă sinteza completă și unificată a **tuturor documentelor atașate**. Puteți copia întregul conținut de mai sus într-un fișier Microsoft Word (.docx), formatați cu titluri, tabele și marcaje, apoi salvați ca „Raport_Unificat_Jamesi_Triplixam_18.04.2026.docx”. Documentul este gata de utilizare

pentru prezentare medicului curant sau radiolog.

Dacă doriți modificări suplimentare, adăugarea de grafice sau versiunea în format PDF, comunicați explicit. Toate informațiile sunt verificate și conforme cu documentația furnizată.